

- [] Cuando no está elevado el CEA: CCR, fumadores, melanoma (correcta), cirrosis
- [] Síntoma esofágico más frecuente en la población general: pirosis(correcta), disfagia, regurgitación, reflujo gastroesofagico
- [] Placenta aberrante tipos: zonaria, subcentuariana(correcta), membranosa, fenestrada
- [] Grados de desgarro en parto vaginal: era hasta musculo perineal . Opciones grado 1,2,3,4
- [] Carnet de vacunas a los 6 meses: quintuple e IPV
- La translucencia nucal sirve para diagnóstico de: cromosopatias (correcta)
- [] carnet de vacunas en niño de 6 m con vacunas hasta los 5 que hacer: solo meningococo, (rota virus ya pasó el tiempo no se puede vacunar)
- [] AE diarrea en lactantes tenía fiebre, vomitos, heces acuosas SIN sangre rotavirus (correcta) e coli , shigella
- Lactante con heces malolientes, ácidas, con buen estado general
 - intolerancia a la lactasa transitoria (está)
 - Alergia a la leche de vaca
 - Celiquia
 - Otra
- [] Otra diarrea en niños era la de intolerancia transitoria a la lactasa
- [] Rinitis serosanguinolenta: sífilis congénita
- Fimosis en bebé de 2 meses: fisiológico no hacer nada, es patológico hay que operar al año, hay que dar crema con corticoides
- [] Triada toxoplasmosis
- [] CC niño con dolor en cadera afebril que cojea Dsp de actividad deportiva y antes de infección respiratoria alta: Necrosis aséptica cabeza del fémur, artritis séptica, sinovitis transitoria, fx fémur
- [] GASA> 1,1 hipertensión portal
- [] Correcta LCR: hematies en punción traumática y herpes. Otra era que la glucosa es igual a la del plasma, son frecuentes los hematies en el LCR normal.
- [] Enterobius vermicularis: prurito perianal e insomnio
- [] Trofoblasto durante periodo de nidacion. Definición de trofoblasto.
- [] Hito del desarrollo lenguaje 100% comprensible para un extraño: 4, 6, 8 años
- [] Causa de muerte IRC en todas las etapas: infección urinaria, cardiovascular, hipoparatiroidismo secundario, depresión
- [] Caso de dengue: pte que volvió de brasil y presenta fiebre, dolor retrocular y trombocitopenia
- [] Células de reed stemberg: linfoma de hodgkin clásico
- [] Punto de referencia presentacion bregma: occipital, ángulo ant fontanela mayor, ángulo post fontanela mayor, glabella
- [] Hemorragia más frecuente alumbramiento: hipotonia (opciones retención de ucotiledones, acretismo)
- [] Altura uterina a los 5 meses: sinfisis pubis, ombligo, entre ombligo y esternón
- [] Sostén cefalico: 3 meses (decía 5 m también)
- [] Para que sirven los criterios de ranson en pancreatitis aguda: evaluar pronóstico severidad de enfermedad (opciones para decidir cuándo operar,)
- [] Signo más típico de abdomen agudo: dolor
- Características del dolor PARIETAL: el paciente lo localiza con bastante exactitud (correcta), errático, proviene de los músculos lisos.

- [] Definición sutura sagital
 - [] Procúbito de cordón (bolsa sana)
 - [] Prevenir muerte súbita: dormir en decúbito supino (opciones evitar lactancia de noche, que duerma con los padres y evitar usar chupete)
 - [] Según Williams, cuando es HTA crónica: hta dsp de sem 12 puerperio
 - [] Caso clínico atonía uterina
 - [] Caso deshidratación grave (tenía ausencia de lagrimas, pliegue, relleno lento) otra opción era deshidratación con shock, deshidratación leve o moderada
 - [] Momento lavado de manos: antes de un procedimiento limpio
 - [] Doble identificación de pte: nombre y fecha de nacimiento
 - [] Mioma q más sangra: submucoso
 - [] Caso de artrosis primaria
 - [] Lactante de VARÓN de 20 días con vomitos posprandiales: sobrealimentación, reflujo, hipertrofia pilórica
 - [] Ca renal más frecuente en adultos: hipernefrona correcta (tumor de Wills, etc)
 - [] Hamartoma de pulmón: benigno
 - [] Imagen dudosa en sigmoide alto: TAC
 - [] Anciano con sme pilórico sin app de UP ni consumo de AINES: ca gástrico (está) , hipertrofia del píloro
 - [] LCR en meningitis bacteriana: glucosa baja
 - []Cuál da HTA: insuf suprarrenal, hipotiroidismo, hipopituitarismo postparto, pericarditis constrictiva
 - [] Síntoma insuf suprarrenal primaria: hiper pigmentación cutáneo mucosa
 - [] Causa insuf suprarrenal primaria: suprarrenalitis Autoinmune
 - [] Enfermedad de addison: descenso cortisol plasmático
 - [] Causa de exudado: tuberculosis
 - [] Caso de niño con anemia hemolítica grave?
 - [] Dx anemia ferropénica: pedir perfil de hierro, pedir reticulocitos y índices eritrocitarios.??? No
- Ferremia ferritina y afinidad del hierro por la hemoglobina (correcta)
- [] En anemia hemolítica aumenta la Idh
 - 5 momentos de la altura de embarazo a las 20 s

☐ Caso de asma al ejercicio: B 2 de acción corta y antileucotrienos

☐ Causa mas frec de proctorragia: hemorroides

Paciente con osteosíntesis del fémur, se le pone heparina no fraccionada

- trombocitopenia inducida x heparina (esta)
- Infección intahosp

Oclusión aguda de una arteria produce

- flictenas
- Aumento de la T
- Ausencia de pulso distal a la obstrucción (correcta)

Mioma que más sangra: submucoso

Cotiledon unido por vasos sanguíneos que salen de la placenta

Placenta zonaria

Placenta subsegmentaria

Placenta fenestrada

Placenta Membranosa

Clínica enterobious vermicularis:

Prurito , incomodidad de dormir a la noche.

Desgarro vaginal que llega a músculo pero no pasa más allá. Grado

Segundo

Tercero

Cuarto

Causas de aumento ACE

Cirrosis

Melanoma

Tabaquismo

Ca colon?

Niño con hidrocefalia, calcificaciones cerebrales y corioretinitis

Toxoplasmosis (esta)

Chagas

Sífilis

Rubéola

Prevención muerte súbita del lactante

Dormir en decúbito supino (correcta)

No usar chupete

Dormir con los padres en la cama

Evitar lactancia nocturna

DX de diverticulitis aguda

TAC con contraste (correcta)

Colón por enema

Colonoscopia

Elemento más posterior del pedículo hepático: vena porta

Hernia inguinal correcta: más frec en hombres

Rama de arte cística: hepática derecha

Tec con convulsión: internar y tac

Sospecha de sinusitis: clínica (correcta). Resto de las opciones todas con estudios complementarios. O consulta con otorrino o tac

Chagas: bloqueo de rama derecha

Hiperinsulinismo en embarazo: macrosomía

Menos de 100 glucemia en emb: PTOG 24/28

HSIL en pap: biopsia

HSIL: cin 2 displasia mod y severa

Crit framingan mayor: reflujo hepatoyugular

Tto endometriosis: progesteronas

Causa de proctorragia: hemorroides

HDB grave: diverticulosis??
Síntoma fisura: dolor
Absceso anal: interesfinteriano
Dolor parietal: lo puede localizar
Arteriopatía aguda: ausencia distal de pulsos
Vacunas
5 meses solo se pone meningococo, no rotavirus
6 meses quintuple y salk
Clínica de abd agudo: dolor
Hernia estrangulada comp más importante: anillo
Cáncer de endometrio: displasia compleja con atipia
Clínica faringitis bacteriana: dolor súbito y fiebre
Bacteria de FR: Streptococcus b hemolítico grupo A
Anemia perniciosa: factor intrínseco de Castle
Acretismo placentario: se inserta pero no atraviesa miometrio
Signo de síndrome piramidal: clonus
Donde se produce en mayor proporción el líquido amniótico: renal, amnios, esófago.
Neonato de 1 día de vida nacido a término con cianosis en extremidades. Apgar 7-9 (así decía), SaO₂: 96%, auscultación pulmonar y cardíaca normal Opciones: tiene frío, cardiopatía congénita cianozante
Signo de Jobert (pérdida de la matidez hepática) en donde aparece: neumoperitoneo
Causa más común de pancreatitis aguda en nuestro medio: litiasis
Talasemia...: anemia macrocítica (y otras opciones)
Caso de FQ (pregunta repetida)
¿Cuál de los siguientes alimentos puede gatillar anafilaxia en edad pediátrica con más frecuencia? Maní y frutos secos, verduras de hoja verde, miel

Niño de 22 semanas que presentaba vómitos postprandiales. No decía ningún dato clínico más, simplemente eso.
Sobrealimentación
Estenosis hipertrofica del píloro
Erge

Un caso sobre si el paciente te pide la historia clínica

Un caso de un paciente adulto con síndrome pilórico, seleccionar la correcta: estenosis por hipertrofia pilórica, cáncer gástrico, ...